

**Diretoria de Assistência à Saúde**  
**Gerência de Enfermagem e Núcleo de Gestão Assistencial**

**Pré-Natal de Risco Intermediário**

Considerando a Deliberação 198/CIB/2021 (SEI 0010460780) que aprovou o novo Instrumento de Estratificação de Risco Gestacional (SEI 0012899947), a gestante classificada como risco intermediário, deve ser acompanhadas pela equipe de APS, com consultas médicas e de enfermagem e avaliação do médico obstetra.

No Risco Intermediário os exames de rotina trimestral (conforme protocolo de pré-natal) devem ser solicitados pelo médico ou enfermeiro que acompanham a gestante.

Seguem as principais patologias que terão o manejo na APS, **onde apenas o médico** poderá solicitar os exames descritos abaixo.

**Quadro 01 – Diabetes Mellitus Gestacional Compensada**

|                     | <b>Diabetes Gestacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Encaminhamento para <b>nutricionista</b>;</li><li>• Encaminhar concomitantemente para teleconsultoria de <b>endocrinologia</b>;</li><li>• As gestantes em <b>tratamento não farmacológico e farmacológico, devem fazer o perfil 1 dia antes e no dia da consulta</b>, com quatro pontos (jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar).</li></ul> |
| <b>Consultas</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Obstetra</b> a cada 15 dias;</li><li>• <b>Nutricionista</b> 15 – 21 dias.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1º trimestre</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• US morfológico (TN) + doppler de 13 semanas;</li><li>• A cada 3 meses solicitar Hemoglobina Glicosilada, Dosagem De (PMV) - (99000848*).</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| <b>2º trimestre</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• US morfológico para avaliar malformações – 20ª a 24ª semana + medidas de colo de útero;</li><li>• US mensal a partir da 24ª semana para avaliar o crescimento fetal e polidrâmnio;</li><li>• A cada 3 meses solicitar Hemoglobina Glicosilada, Dosagem De (PMV) – (99000848*).</li></ul>                                                      |
| <b>3º trimestre</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• US mensal até o parto. Em caso de suspeita de RCIU ou feto grande para a idade gestacional, realizar avaliação a cada 15 dias;</li><li>• A cada 3 meses solicitar Hemoglobina Glicosilada, Dosagem De (PMV) – (99000848*).</li></ul>                                                                                                          |

Fonte: BRASIL, 2022; SC, 2021- Adaptado

\* Códigos referentes ao sistema SIG –SaúdeTech.

**Quadro 02 – Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) Crônica Compensada**

|                     | <b>Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) Crônica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Encaminhar concomitantemente para teleconsultoria de <b>cardiologia</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Consultas</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Obstetra</b> a cada 15 dias;</li><li>• <b>Nutricionista</b> a cada 30 dias.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1º trimestre</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Creatinina, Dosagem De - SANGUE (PMV) - (99000840*);</li><li>• Ácido Úrico, Dosagem De - SANGUE (PMV) - (99000846*);</li><li>• Proteínas, Dosagem De - URINA isolada (PMV) - (99001049*) - Creatinina, Dosagem De - URINA isolada (PMV) - (99002833*) - (RPC);</li><li>• US obstétrica + TN (11 – 14s) + doppler.</li></ul> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2º trimestre</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteínas, Dosagem De - URINA isolada (PMV) - (99001049*) - Creatinina, Dosagem De - URINA isolada (PMV) - (99002833*) - (RPC);</li> <li>• Em cada consulta, a partir das 20 semanas, solicitar Ácido Úrico, Dosagem De - SANGUE (PMV) – (99000846*);</li> <li>• US Morfológico com 22 semanas e mensal a partir das 30 semanas;</li> <li>• Controle pressórico (MRPA) em cada consulta.</li> </ul> |
| <b>3º trimestre</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteínas, Dosagem De - URINA isolada (PMV) - (99001049*) - Creatinina, Dosagem De - URINA isolada (PMV) - (99002833*) - (RPC);</li> <li>• US Morfológico mensal a partir das 30 semanas;</li> <li>• Controle pressórico (MRPA) em cada consulta.</li> </ul>                                                                                                                                        |

**Fonte:** BRASIL, 2022; SC, 2021- Adaptado

\* Códigos referentes ao sistema SIG –SaúdeTech.



## REFERÊNCIAS

- 1 BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Sociedade Brasileira de Diabetes.
- 2 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. **Manual de gestação de alto risco**. Brasília – DF: 2022.
- 3 ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Maternidade Darcy Vargas. **Protocolos de assistência obstétrica**: Maternidade Darcy Vargas. Joinville – SC: 2021.

